

阴道悬吊手术通过将阴道顶端或子宫重新固定于自体盆腔韧带来修复顶端脱垂 — 使用您自身组织，无需网片。手术完全经阴道完成，无需腹部切口，是一种持久、无网片的支撑修复方法，可恢复阴道深度。

关于这项手术

手术将阴道顶端缝合固定于盆腔内的坚韧韧带上。常用的两种术式为：

- **子宫骶骨韧带悬吊术（USLS）** — 固定于盆腔深处的子宫骶骨韧带
- **骶棘韧带固定术（SSLF）** — 固定于侧方的骶棘韧带

两种术式均使用**自体组织**（永久性缝线），避免使用网片。常与前壁或后壁修补联合进行，如需切除子宫，可同期完成。

与其他术式的比较

与**骶骨阴道固定术**（经腹用网片上提阴道）相比，阴道悬吊无需网片，也无需腹部切口；骶骨阴道固定术的持久性可能略优。您的医生会帮助您权衡各方面因素。

名词解释

顶端 / 穹隆

阴道顶部，脱垂时会向下移位。

悬吊

将阴道顶端重新固定于坚韧韧带上。

USLS

子宫骶骨韧带悬吊术。

SSLF

骶棘韧带固定术。

自体组织

您自身的组织 — 此手术不使用网片。

穹隆脱垂

阴道顶端下垂，常见于子宫切除术后。

会疼吗？ 手术在麻醉下进行，过程中您不会有任何感觉，且无腹部切口。骶棘韧带固定术后，部分患者在愈合过程中可能出现数天至数周的**臀部或大腿上方不适** — 通常可自行缓解。

如何准备

- 遵照**麻醉指示**（禁食、按医嘱停用抗凝药）。
- 完成术前评估；可能同期联合其他修补或抗漏尿手术。
- 戒烟；安排接送及术后居家照护。

手术过程

- 1 麻醉后，预防性使用抗生素。
- 2 经阴道将阴道顶端缝合固定于盆腔坚韧韧带上。
- 3 按计划完成其他阴道壁修补。
- 4 留置导尿管，必要时短暂放置阴道填塞。

术后注意事项

- 当日出院或留院一晚；少量点滴出血或分泌物属正常现象。
- **约6周内避免重物搬运、用力及性生活。**
- SSLF术后臀部不适通常在数周内缓解；保持大便通畅。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战，或大量出血
- **无法排尿**，或盆腔疼痛加重
- **臀部或腿部剧烈或放射性疼痛**，或新出现麻木

需要记住的三件事

1. 阴道悬吊手术利用自体韧带上提阴道顶端 — 持久、无网片，经阴道完成。
2. 常用术式为USLS和SSLF；如需比较，骶骨阴道固定术是使用网片的经腹替代方案。
3. 约6周内避免重物搬运和性生活。SSLF后可能有轻度臀部酸痛；如出现发热、大量出血或腿部/臀部剧烈疼痛，请及时就医。